

ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA

Juan Carlos Fletes Lacayo

INTRODUCCIÓN

Se define como un proceso sindrómico que se produce por la pérdida más o menos súbita de flujo sanguíneo en un territorio concreto, siendo las extremidades inferiores más comúnmente afectadas que las superiores, dependiendo del tiempo de instauración la viabilidad de la extremidad puede estar comprometida.

Hombres y mujeres se afectan por igual, con una edad media de 75 años, sus principales factores de riesgos son: edad, hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, obesidad, sedentarismo e historia familiar de enfermedad vascular.

Etiopatogenia

- **Trombótica:** forma más común de presentación en presencia de enfermedad arteriosclerótica previa en extremidades inferiores. Aneurisma poplíteo trombosados. Post-intervención quirúrgica por trombosis del by pass o stents implantados.
- **Embólica:** generalmente de origen cardíaco (fibrilación auricular, trombo ventricular tras IAM o disfunción ventricular, patología o prótesis valvulares), Arterio-arterial (aneurisma torácico o abdominal o ateroembolismo por lesión arterial próxima).
- **Iatrogénica:** intervención endovascular (cateterismo cardiaco, arteriografía periférica)
- **Traumática:** laceraciones o traumatismos arteriales abiertos o cerrados.
- **Otros:** trombofilias y trombosis venosa profunda (flegmasia).

DIAGNÓSTICO

- **Anamnesis:** antecedentes personales, factores de riesgo, tiempo de instauración del dolor.
- **Exploración Física:** se resume a las "5 P:" pain (dolor), palidez, parestesias, parálisis y pulseness (ausencia de pulsos) en la extremidad afectada.
- **Pruebas complementarias:**
 - Hemograma.
 - Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, amilasa, bilirrubina, CP-K, Equilibrio ácido base, lactacidemia, PCR.
 - Coagulación básica.
 - ECG
 - Rx Tórax PA y Lateral.
 - Exploración doppler continuo / Ecodoppler arterial
 - AngioTAC salvo contraindicación (alergia a contrastes / insuficiencia renal severa)

TRATAMIENTO

- Estabilización hemodinámica :
 - Control de constantes y oxigenoterapia.
 - Colocar extremidad afectada en posición de declive y evitar la compresión sobre el talón o prominencias óseas.
 - Fluidoterapia (suero fisiológico)
- Analgesia:
 - Analgesia no opioide: paracetamol 1 gr IV o Metamizol 1 amp IV.

- Analgesia opioide: dolantina 1/2 amp IV. o Morfina IV según control de analgesico.
- Anticoagulación sistémica si no contraindicación y previa consulta cirugía vascular.
 - **Heparina sódica intravenosa:** 100 / 150 UI/kg en bolo, seguida de infusión 18 UI/kg/h, ajuste posterior según TTPa.
 - **HBPM:** 1 mg/Kg cada 12 horas o 1,5 mg/kg cada 24 horas.
- Control de patologías asociadas que puedan empeorar cuadro clínico: Hipotensión arterial, arritmias, insuficiencia cardiaca, hipoxemia.
- Consulta urgente a cirugía vascular o traslado a centro de referencia.

PUNTOS CLAVES

- Antecedes de arteriosclerosis y/o cardiopatía (fibrilación auricular).
- “5P” Dolor de instauración brusca (pain) asociado a palidez, frialdad, ausencia de pulsos y parestesias.
- Colocación de extremidad en posición de declive.
- Anticoagulación sistémica y control del dolor

BIBLIOGRAFÍA

- Fukuda, I, Chiyoya M, Taniguchi S, Fukuda W. Acute limb ischemia: contemporary approach. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2015;63(10):540-548.
- Henke PK. Contemporary Management of Acute Limb Ischemia: Factors Associated with Amputation and In-Hospital Mortality. Semin Vasc Surg. 2009;22(1):34-40.
- Martín Conejero A, Galindo García A, Moñux Ducajú G, Marínez López I, Sánchez Hervás L, Serrano Hernando FJ. Isquemia arterial aguda, Medicine.2017;12(41):2433-2439.